

Depresión

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es la depresión?

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta la forma en que una persona siente, piensa y funciona. No es tristeza pasajera ni una falla de carácter.

Tiene base neurobiológica, psicológica y social, y responde bien al tratamiento cuando se interviene a tiempo.

Tristeza vs. depresión:

Dimensión	Tristeza · Depresión
Duración	Pasajera y vinculada a una causa · Persistente (más de 2 semanas)
Impacto funcional	No impide el funcionamiento · Interfiere significativamente en la vida
Estado de ánimo	Fluctúa, puede mejorar momentáneamente · Bajo casi todo el tiempo
Capacidad de placer	Se puede disfrutar de actividades · Anhedonia: pérdida del placer en casi todo

Factores etiológicos:

- Biológicos: genética, alteraciones en neurotransmisores (serotonina, dopamina, noradrenalina)
- Psicológicos: historia de pérdidas, trauma, patrones cognitivos negativos, baja autoestima
- Sociales: aislamiento, falta de apoyo, situaciones de vida adversas o prolongadas

02. Presentación clínica

Síntomas emocionales: tristeza persistente o vacío emocional, irritabilidad, anhedonia, culpa excesiva.

Síntomas cognitivos: pensamientos negativos automáticos, dificultad para concentrarse, visión negativa de sí mismo/mundo/futuro (tríada cognitiva de Beck), pensamientos sobre la muerte.

Síntomas físicos: fatiga, alteraciones del sueño, cambios en el apetito y el peso, enlentecimiento o agitación psicomotriz.

Síntomas conductuales: aislamiento social, abandono de actividades significativas, descuido del autocuidado, dificultad para sostener responsabilidades.

03. El ciclo de la depresión

La depresión se sostiene a través de un ciclo que se retroalimenta:

- Estado de ánimo bajo y pérdida de motivación
- Reducción de actividades que antes daban placer o sentido
- Aumento del aislamiento y la rumiación negativa
- Pensamientos automáticos negativos ("no sirvo para nada", "nunca va a mejorar")
- Mayor caída del ánimo y la energía — el ciclo se refuerza

Nota clínica: La depresión compromete exactamente las herramientas necesarias para salir de ella: energía, motivación, esperanza. Por esto, esperar a "tener ganas" para actuar no es una estrategia viable.

04. Lo que mantiene y lo que ayuda

Mantiene la depresión	Favorece la recuperación
Inactividad y aislamiento	Activación gradual con acciones concretas y pequeñas
Rumiación y autocrítica	Identificación y cuestionamiento de pensamientos automáticos negativos
Evitar actividades placenteras	Reintroducción progresiva de actividades aunque no haya motivación previa
Esperar sentirse mejor para actuar	Actuar antes de tener ganas (la acción precede al estado de ánimo)
Horarios de sueño irregulares	Regularización del ciclo sueño-vigilia
Aislamiento relacional	Mantener conexión social, aunque sea mínima

05. Activación conductual

Intervención con alta evidencia empírica. Se basa en el principio de que la acción precede al estado de ánimo.

- Identificar UNA actividad pequeña y concreta para realizar hoy
- No requiere que sea placentera en el momento, solo que antes lo fuera
- Registrar el estado emocional antes y después de realizarla
- La acumulación de pequeñas acciones reconstruye el circuito del placer

06. Mitos y realidades

Mito	Perspectiva clínica
"Ya se le va a pasar"	La depresión es una condición que requiere tratamiento activo.
"Ponele voluntad"	La voluntad no alcanza cuando el sistema nervioso está comprometido.
"La medicación te cambia"	La medicación adecuada restaura el equilibrio sin alterar la identidad.
"Es para siempre"	La mayoría de los episodios se recuperan con tratamiento.